Anamnesefragen

- Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
- Wo genau sind die Schmerzen?
- Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
- Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen? z. B. Essen, Getränke?
- Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?
- Ist es das erste Mal oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
- Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
- Haben Sie Luftnot, Brustschmerzen oder ein Engegefühl?
- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Herzrasen, Kaltschweißigkeit, Schwindel oder Müdigkeit haben?
- Leiden Sie unter einem harten und aufgeblähten Bauch?
- Mit wem haben Sie gegessen? Gibt es jemanden, der mit Ihnen zusammen gegessen hat? Hat jemand dasselbe gegessen und ähnliche Beschwerden?
- War das Essen noch frisch? Hat es vielleicht ein bisschen komisch geschmeckt?
- Wo haben Sie gegessen? Haben Sie selbst gekocht?
- Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie drückend oder kolikartig?
- Wie stark sind die Schmerzen (0–10)?
- Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt oder lindert? z.B. Bewegung, Essen
- Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen?
- Haben Sie Fieber oder Schüttelfrost?
- Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?

- Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?

- Haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Wie sieht es mit dem Wasserlassen aus? Ist alles in Ordnung?

- Leiden Sie unter Völlegefühl oder Blähungen?

- Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Sodbrennen oder saures Aufstoßen haben?

- Treten die Beschwerden auf, wenn Sie bestimmte Nahrungsmittel konsumieren – zum Beispiel Brot, Nudeln oder Milchprodukte?

Am Ende des Gesprachs- Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf **Magen-Darm-Entzündung** (akute Gastroenteritis). Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.
Es geht um **Frau Maria Stettner**. Sie ist **62 Jahre alt**, am **01.03.1960** geboren, **167 cm groß** und wiegt **69,5 kg**.

Sie stellt sich wegen seit gestern Abend bestehender **kolikartiger, wellenförmiger, persistierender und diffuser Bauchschmerzen** vor.
Die Schmerzen strahlen **nicht aus**. Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen **nach dem Essen langsam aufgetreten**. Sie hat ein **Mettbrötchen** gegessen.
Die Schmerzen **verstärken sich bei Bewegung**, während sie sich **nach Erbrechen bessern**.

Begleitend klagt sie über **Übelkeit und dreimaliges Erbrechen**, das gelblich, schleimig, breiig und mit unverdautem Essen war.
Sie hatte **fünfmal Durchfall seit heute Morgen**, wässrig, schaumig, zunächst **hellrot**, jetzt **dunkelrot**.
Sie berichtet außerdem über **Herzrasen und Appetitlosigkeit**.
Heute Morgen hatte sie **Fieber mit 38,3 °C**.

Vegetativanamnestisch ergaben sich **Müdigkeit, Husten und Schlafstörungen wegen Stress**.

Bei der **Vorerkrankungsanamnese** erwähnte sie **beidseitige drückende Kopfschmerzen**, **Reizmagen** und **Rauherhusten**.
Sie hatte **keine Operationen**. Bei der Geburt ihrer Tochter wurde jedoch eine **Glockenextraktion** durchgeführt.

Bei der **Medikamentenanamnese** ergab sich die Einnahme von **Baldrian bei Bedarf**, **ASS 500 mg** und **Maloxon bei Bedarf**.
Die **Allergieanamnese** war unauffällig, **bis auf eine Allergie gegen Amoxicillin**, auf das sie **mit anaphylaktischem Schock reagiert**.

Bei der **Noxenanamnese** erwähnt sie **täglich 10 Zigaretten seit dem 16. Lebensjahr** sowie **2 Gläser Wein am Wochenende**. Drogen werden verneint.

Die **Familienanamnese** ergab **ein Myokardinfarkt beim Vater**, daran gestorben, sowie **Brustkrebs bei der Mutter**, daran gestorben.

Sozialanamnestisch ist sie **Taxifahrerin von Beruf**, **geschieden** und wohnt **allein**.
Sie hat eine **Tochter**, die **drogenabhängig ist** und sich derzeit im **Methadon-Programm** befindet.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine akute Gastroenteritis hin. der akute Beginn nach dem Verzehr von rohen tierischen Produkten, die progredienten kolikartigen Bauchschmerzen, das Erbrechen und der blutige Durchfall sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen akute Pankreatitis, Ulcus ventrikuli, ACS, cronische entzündliche Darmerkrankungen (bei positiver Familienanamnese) in Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überwachen und Blut fürs Labor abnehmen. Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, BZ, Lipase, Amylase sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT(Fecal occult Blood Test) und Stuhlkultur) kontrollieren lassen. Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden.???? Anschließend werde ich eine Sonographie-Abdomen, ggf. CT-Abdomen und ggf. ÖGD und Koloskopie durchführen und ein Konsil in der Gastroenterologie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patienten stationär aufgenommen werden. Als initiale Therapie empfehle ich Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution, anschließend magenschonende Ernährung (z.B.Kartoffeln, Reis und Apfel) Analgetika (z.B.Metamizol), Antiemetikum, Antipyretikum und Spasmolytika (z.B. Tolperison, Methocarbamol, Tizanidin, Baclofen), sowie Nikotinkarenz und Alkoholkarenz. Nach Erregernachweiß kann ein Antibiotikum (Ciprofloxacin) eingesetzt werden. Außerdem fordere ich ggf. ein Gastroenterologie-Konsil an.

Reaktionen:

Geburt mit Saugglocken, ist das eine OP? Gastroenteritis

Die Saugglocke: çocuk çekme başlığı (bei der Geburtshilfe)

Die Saugglocke ist eine Maßnahme während der vaginalen Geburt.

Diese Methode wird bei Bedarf immer noch verwendet.

z.B. Wenn das Baby Probleme hat, den Geburtskanal zu passieren, benutzen wir. In vielen Fällen kann die Verwendung einer Saugglocke dazu beitragen, einen Kaiserschnitt zu vermeiden.

Beitragen zu: katkıda bulunmak

Sterben auch junge Leute an HI? Gibt es andere Therapien heutzutage für HI? Gastroenteritis

Ja, auch junge Menschen können an einem Herzinfarkt (HI) sterben, obwohl es seltener als bei älteren Menschen ist.

Ein Herzinfarkt kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B. genetische Vorbelastung, ungesunde Lebensstilgewohnheiten wie Rauchen, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und hoher Stress.

Ja, es gibt neue Behandlungsmethoden, es gibt Fortschritte.

Ist Methadon gefährlich? Kann man darauf verzichten? Gastroenteritis

Das Methadon-Programm ist eine Ersatztherapie bei der Drogenabhängigkeit.

verzichten: vazgeçmek

Natürlich hat jede Therapie Vor- und Nachteile. **Aber unter ärztlicher Aufsicht** ist es sicher und wirksam. Es ist eine schwierige Situation, aber sie soll dranbleiben. Nach dem Programm sollte ihre Tochter hoffentlich drogen- und methadonfrei sein.

Gastroenteritis – Überblick (kurz)

1. Formen der Gastroenteritis

- **Virale Gastroenteritis**
  z.B. **Norovirus, Rotavirus, Adenovirus**
  → sehr ansteckend, häufig in Gemeinschaftseinrichtungen
- **Bakterielle Gastroenteritis**
  z.B. **Salmonellen, Campylobacter, Shigellen, E. coli**
- **Parasitäre Gastroenteritis**
  z.B. **Giardia lamblia, Entamoeba histolytica**
- **Toxinbedingt / Lebensmittelvergiftung**
  z.B. **Staphylococcus aureus, Bacillus cereus**

---

2. Isolation – ja oder nein?

👉 **Ja, bei infektiöser Gastroenteritis ist Isolation notwendig.**

Virale Gastroenteritis:

- Isolation **mindestens 48 Stunden nach Sistieren der Symptome** (v. a. Durchfall/Erbrechen)
- Norovirus: sehr hohe Kontagiosität

Bakterielle Gastroenteritis:

- Isolation **bis Symptomfreiheit**, bei bestimmten Erregern (z.B. Shigella, Salmonella typhi) ggf. **bis negative Stuhlproben**

---

3. Häufige Erreger in Lebensmitteln

Rohes / nicht durchgegartes Fleisch:

- **Salmonella spp.**
- **Campylobacter jejuni**
- **E. coli (EHEC)**

Verdorbene Milch / Milchprodukte:

- **Listeria monocytogenes**
- **Staphylococcus aureus**

- **Bacillus cereus**

Kurz-Zusammenfassung

Thema	Antwort
Formen	viral, bakteriell, parasitär, toxinbedingt
Isolation	Ja, bei infektiöser GE
Viral	bis 48 h nach Symptomende
Bakteriell	bis symptomfrei / ggf. negative Stuhlproben
Rohes Fleisch	Salmonellen, Campylobacter, E. coli
Verdorbene Milch	Listerien, Staph. aureus, Bacillus cereus

Formen der Gastroenteritis mit typischen Erregern (Beispiele)

1. Akute, nicht-entzündliche Gastroenteritis

→ wässriger Durchfall, kein Blut, wenig Fieber
Typisch bei: Norovirus, Rotavirus, enterotoxische E. coli (ETEC)

„Die akute, nicht-entzündliche Gastroenteritis zeigt sich mit wässrigem Durchfall ohne Blut, typisch z.B. bei Norovirus oder ETEC."

---

2. Akute, entzündliche Gastroenteritis (Sekretionstyp (wassrig), Invasiontyp, (schleimig-blutig) Penetrationstyp(leichte blutig))

→ Fieber, Bauchschmerzen, evtl. Blut im Stuhl
Typisch bei: Campylobacter, Shigella, Salmonella, EHEC

„Die akute, entzündliche Gastroenteritis ist gekennzeichnet durch Fieber und eventuell blutigen Durchfall, z.B. bei Campylobacter oder Shigellen."

---

3. Chronische Gastroenteritis

→ > 2–4 Wochen, Gewichtsverlust, Müdigkeit
Typisch bei: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, chronisch entzündliche Darmerkrankungen

„Eine chronische Gastroenteritis findet man z.B. bei Giardia lamblia oder bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen."

---

4. Antibiotika-assoziierte Gastroenteritis

→ nach Antibiotikatherapie
Typisch bei: Clostridioides difficile

„Die antibiotikaassoziierte Gastroenteritis wird typischerweise durch Clostridioides difficile verursacht."

---

5. Reisegastroenteritis

→ nach Auslandsreise
Typisch bei: ETEC, Campylobacter, Shigella

„Die Reisegastroenteritis wird häufig durch enterotoxische E. coli oder Campylobacter ausgelöst."

---

6. Toxinvermittelte Gastroenteritis

→ sehr schneller Beginn (1–6 h) nach Essen
Typisch bei: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus

„Die toxinvermittelte Gastroenteritis beginnt sehr rasch nach dem Essen, z.B. bei Staphylococcus aureus."

Kurz-Zusammenfassung

Form	Typische Erreger
Akut, nicht-entzündlich	Noro-, Rota-, ETEC
Akut, entzündlich	Campylobacter, Shigella, Salmonella, EHEC
Chronisch	Giardia, Entamoeba
Antibiotika-assoziiert	C. difficile

Form	Typische Erreger
Reise	ETEC, Campylobacter
Toxinbedingt	Staph. aureus, Bacillus cereus

„Nach dem Verzehr von rohem Schweinefleisch kommen vor allem Salmonellen und Yersinia enterocolitica als Erreger einer Gastroenteritis in Betracht."

Biraz daha ayrıntı istersen:

- **Salmonella spp.** → akute, entzündliche Gastroenteritis mit Fieber und Durchfall
- **Yersinia enterocolitica** → Bauchschmerzen (oft rechts), Fieber, Diarrhö, kann Appendizitis imitieren

„Typisch nach rohem Schweinefleisch sind Salmonellen oder Yersinia enterocolitica.

Diarrhö – 3 Kriterien (korrekt formuliert)

„Eine Diarrhö ist definiert durch mehr als drei Stuhlentleerungen pro Tag, eine verminderte Stuhlkonsistenz (ungeformt oder wässrig) und ein erhöhtes Stuhlgewicht von mehr als 200–250 g pro Tag."

Diarrhö tipleri (klinik sınıflamaya göre)

1. Akute Diarrhö

- Süre: < 14 gün
- En sık enfeksiyöz nedenli

„Die akute Diarrhö dauert weniger als 14 Tage und ist meist infektiös bedingt."

---

2. Persistierende Diarrhö

- Süre: 14–28 gün

„Eine persistierende Diarrhö besteht länger als 14 Tage.“

---

3. Chronische Diarrhö

- Süre: > 4 hafta

„Von einer chronischen Diarrhö spricht man bei einer Dauer von mehr als vier Wochen.“

---

4. Sekretorische Diarrhö

- Büyük miktarda sulu dışkı, açlıkta da devam eder

„Die sekretorische Diarrhö ist durch große Mengen wässrigen Stuhls gekennzeichnet und persistiert auch bei Nahrungskarenz.“

---

5. Osmotische Diarrhö

- Aç kalınca azalır

„Die osmotische Diarrhö bessert sich typischerweise bei Nahrungskarenz.“

---

6. Entzündliche Diarrhö

- Kan, mukus, ateş olabilir

„Die entzündliche Diarrhö geht oft mit Fieber sowie Blut- oder Schleimbeimengungen im Stuhl einher.“

---

7. Motorische (hypermotile) Diarrhö

- Hızlı bağırsak pasajı

„Die motorische Diarrhö entsteht durch eine beschleunigte Darmpassage.“

= entzündung der Muskelsehnen und deren Scheiden

1

Ätiologie:

- **Überbelastung** der entsprechenden Muskelsehnen in den meisten Fällen. Durch Fehlhaltung kommt es zu kleinen Verletzungen der Sehnen (CTD = cumulative Trauma Disorders). Meist beruflich bedingt: Klavierspieler, Handwerker oder Personen, die länger am Computer arbeiten
- **Immunologische** Ursachen: nach Infektionen mit Chlamydien, Mykoplasmen, Borrelien, Gonokokken (gebildeteten Antikörper gegen die Erreger reagieren auch auf körpereigenes Gewebe)
- **Infektionen**: oder durch eine direkte bakterielle Infektion (mit Schnitt-, Stichverletzungen) meist sind Streptokokken oder Staphylokokken die Auslöser.

plötzlich X allmählich

10. Akute Gastroenteritis s.75

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

01.03.1960 -> erster Dritter neunzehnhundertsechzig
am 01.03.1960 -> am ersten Dritten neunzehnhundert-sechzig

- Name: Maria Stettner
- Alter: 62 (01.03.1960)
- Größe: 1,67 m
- Gewicht: 69,5 kg

-Hauptbeschwerde

- Bauchschmerzen
  - Seit gestern Abend
  - Oberbauch (Epigastrium)
  - Diffus, kolikartig, wellenförmig: dumpf, krampfartige, wellenförmig
  - Dauerhaft (persistierend)
  - Keine Ausstrahlung
  - Nach dem Verzehr von Mettbrötchen / Tiramisu ~~Könnten die Schmerzen wegen des Essens sein?~~ Ja das ist möglich. ~~Wo~~ Wie haben Sie das Tiramisu gefunden? ~~Es ist mit Milch gefüllt, also muss es im Kühlschrank bleiben~~.
    Mettbrötchen Hat es vielleicht ein bisschen komisch geschmeckt?
    - X Mettbrötchen ist eine Spezialität mit rohem Schweinefleisch auf Brot, mit rohen Zwiebeln.
    - X Das Fleisch möglicherweise Parasiten enthielt, da es nicht gekocht wurde. Wo haben Sie es gekauft?
  - Langsam angefangen
  - Verschlechterungsfaktor: Bewegung
  - Minderungsfaktor: Vomitus
- Nausea: Übelkeit
- Vomitus: ich habe mich drei Mal übergeben
  - 3 Mal: Wie sah das Erbrechen aus?
  - Unverdautes Essen, gelblich, schleimig, breiig *(= pâteux)*
- Diarrhö: Durchfall Wie oft Durchfall und seit wann? Wie sieht der Stuhl aus?
  - Seit heute Morgen
  - Wässrig, schaumig und hellrot jetzt dunkelrot
- Herzrasen ~~Woraus kommt Herzrasen~~?

→ Dehydrierung

- Starke Durchfälle können zu einem Elektrolytungleichgewicht führen, das Herzrhythmusstörungen wie Palpitationen verursachen kann.

→ Hochgradige starke Durchfälle können zu Herzrasen führen.

(2)

- Haben Sie Brustschmerzen?
- Atemnot?
- Gibt es in der Familie noch jemanden, der unter Durchfall leidet?
- Reise?
- Könnte es sein, dass das Essen verdorben war? *(ist nicht mehr gut)*

-vegetative Symptomatik

- Fieber + (gestern 39, heute 38,3 axillär gemessen)
- Müdigkeit + (seit gestern Morgen)
- Inappetenz + (seit gestern Morgen)
- Husten +
- Insomnie +
- Stress + (wegen Konkurrenz bei der Arbeit und Drogenabhängigkeit der Tochter)

-gyn

- Menopause vor 7 J.
- Entbindung mit Geburtszang *(= accouchement avec forceps)*

-Vorerkrankungen

- Kopfschmerzen
  - Bds.
  - Drückend
- Reizmagen/ähnliche Beschwerden
  - 1/M (Dyspepsie): ich habe auch Sodbrennen einmal pro Monat
- Raucher Husten (chronische Tussis): ich huste seit etwa zehn Jahren jeden Tag
- ~~Seit Langem habe ich meinen HA nicht besucht.~~
  - Es ist sehr wichtig, einen Hausarzt zu haben und ihn regelmäßig zu konsultieren.

-Vor-OPs

- Vakuumextraktion vor 27 J.: ~~Geburt mit Saugglocken, Ist das eine OP?~~
  - Nein, es ist keine Operation, ~~ein Kaiserschnitt ist zum Beispiel eine Operation.~~
  - Haben Sie schon einmal in einem Operationssaal gestanden und ein Betäubungsmittel erhalten?

Die Saugglocke ist eine Maßnahme während der vaginalen Geburt. Diese Methode wird bei Bedarf immer noch verwendet.

-Medikation

- Baldrian b.B. (schlaffördernd und beruhigend Mittel)
- ASS 500 mg b.B. (gegen KS)
- Maaloxan gegen Bauchschmerzen

-Allergien

- Amoxicilline (Dyspnoe): Ich hatte Atemnot, und wurde ins Krankenhaus gebracht, um mir Adrenalin zu spritzen

-Noxen

- Tabak: 10 Zig./d seit 16 LJ ~~Ich möchte nur Hilfe für meine Schmerzen~~
  - Ich verstehe, dass Sie sich hauptsächlich auf Ihre Schmerzen konzentrieren möchten.
  - Rauchen aufzuhören kann Ihnen aber auch helfen, Ihre Schmerzen langfristig zu lindern.
- C2: 2 Gl. Wein /W und gel. Bier
- Drogen:-

-Sozialanamnese

- Taxifahrerin (viel Stress)
- Geschieden, wohne allein
- 1 Tochter: Drogenabhängigkeit, momentan unter Methadonprogramm
  - ~~Ist Methadon gefährlich? Kann man darauf verzichten?~~
    - Oh ja. Das verstehe ich. Methadon ist eine schwere Droge. Ihre Tochter hat Glück, dass sie in ein Programm aufgenommen wurde.
    - Ein Methadon-Programm ist eine medizinische Behandlung für Menschen mit Opioidabhängigkeit, bei der Methadon als Ersatz für andere Opiate verabreicht wird, um Entzugserscheinungen zu lindern und die Sucht zu kontrollieren, wobei die Dosierung schrittweise reduziert wird, damit die Patienten hoffentlich am Ende des Programms drogenfrei sind.

Methadonprogramm ist eine Therapieform für langjährige Heroinsüchtige.

- Reise -

-Familienanamnese

- Vater: t mit 45 an MI
  - ~~Sterben auch junge Leute an HI? Gibt es andere Therapien heutzutage für HI?~~
    - Das ist möglich, aber extrem selten. Es gibt heute neue Therapien, um HI zu heilen, und vor allem Vorsorgeuntersuchungen, um es zu diagnostizieren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Ihren Hausarzt besuchen.
- Mutter: t mit 65 an Mamma-CA
  - ~~Habe ich auch Krebs?~~
    - Ich möchte Sie beruhigen, denn Ihre Beschwerden deuten nicht auf einen Krebs hin. Aber wir werden ein paar Untersuchungen durchführen, sodass wir sicher sein können, dass alles in Ordnung ist.

Ich verstehe, dass Sie Angst haben, weil ihr Mutter an Krebs verstorben ist. Aber ich gehe nicht davon aus

Bitte machen Sie sich keine Sorge.

⇨ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht auf **Magen-Darm-Entzündung** (akute Gastroenteritis).
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde Ihnen zuerst Ihren Körper untersuchen. Dann werde ich Ihnen Blut abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sonographie:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

-Fragen

- Was machen Sie für mich?
- Könnten Sie mit Ultraschall verstehen, ob ich Krebs habe?
  - Ja, wir können ihn normal sehen, und wenn wir weitere Untersuchungen brauchen, werden wir diese in einem zweiten Schritt nach einer Beratung durch einen Darm Arzt durchführen.
- Welche Laboruntersuchungen?
- Soll ich im KH bleiben?
  - Ja sie müssen im Krankenhaus bleiben, bis wir wissen, warum sie Blut im Stuhl haben. Aber seien Sie beruhigt, es ist wahrscheinlich, dass es nur wegen einer Magen-Darm-Grippe ist.
- Wie kann man den Stuhl untersuchen?

Momentan kann ich nicht genau sagen. Wir warten die Blutuntersuchung, dann entscheiden wir.

Letzten endscheidung in Hand arzt oder

Seien Sie beruhigt, wir kümmern uns um Sie, Machen Sie sich bitte keine Sorge. Sie sind in guten Händen

- Die Stuhlprobe wird vom Patienten selbst aus dem normal abgesetzten Stuhl entnommen. Dafür erhält man vom Arzt ein Stuhlentnahme-Set mit Stuhlröhrchen, Löffel und Schraubverschluss. Der Stuhl soll nicht in Kontakt mit dem Urin oder Spülwasser kommen.

Stuhl absetzen → dispo gepmoz

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Maria Stettner, 62** Jahre alt, der in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit gestern Abend diffuse kolikartige persistierende abdominale Schmerzen im Epigastrium. Die Schmerzen haben langsam begonnen nach dem Verzehr von Mettbrötchen (aus der Bäckerei) und ein Tiramisu (das über Nacht aus dem Kühlschrank gelassen wurde), und sind seitdem progredient. 5 von 10 auf einer Schmerzskala. Lindernd ist nach dem Vomitus und verstärkend ist Bewegung.

Begleitend ist seit ? Nausea, Vomitus, Diarrhoe mit Hämatochezie.

Sie berichtet auch Fieber: gestern 39, heute 38,3 axillär gemessen. Fatigue / Asthenie, Inappetenz und Insomnie wegen Stress. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie hat seit ? chronische Cephalgie und nimmt regelmäßig dagegen ASS 500 mg. Sie leidet auch an Dyspepsie seit ? und nimmt dagegen gelegentlich Maaloxan. Sie nimmt auch Baldrian bei Bedarf gegen Ihren Stress ein.

Sie ist allergisch gegen Penicillin.

In der Familienanamnese gibt es ihr Vater starb mit 45 Jahren an einem Myokardinfarkt.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf akute Gastroenteritis. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Lebensmittelvergiftung, Ulcus ventriculi, ACS

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, CRP, BSG, ggf. PCT, Gerinnungsparameter (PT), Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Herzenzyme (Trop.I, T, CKMB), Glukose, und eine Stuhluntersuchung + Kultur und FOBT (Fäkaler okkulter Bluttest).

Anschließend ist eine Sonographie des Abdomens. Auch sollte ein Ruhe-EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache zu vermeiden. Sollten diese Untersuchungen noch keine Klarheit bringen, wäre eine ÖGD angezeigt. Weiterführend ist ein Gastroenterologische Konsil anzufordern.

5

Ich werde sie stationäre aufnahmen (wegen blütiger Diarrhoe).

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch Flüssigkeits und Elytsubstitution (Infusiontherapie), Antiemetika, Antipyretika, Analgetikum (Metamizol) b.B., Magenschonende Ernährung (Nikotinkarenz und Alkoholkarenz) vor.
Bei gesicherter Verdachtsdiagnose empfehle ich Antibiotikum (Ciprofloxacin) und Probiotika.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Warum? Was hat er dagegen? Wegen der Lebensmittelvergiftung. Der Körper reagiert auf Kontakt mit Mikroorganismen, um diese aus dem Körper zu entfernen.

Warum haben die Gerichte eine GE verursacht? Weil sie nicht frisch waren / **Häufigste Erreger der GE (Bakterien, Viren)?** Mikroorganismen besiedeln leicht ungekochte Lebensmittel. Ungekochte Fleische ist ein Risikofaktor bei einer sogenannten Yersiniose
ungenau

- Viren: Noroviren und Rotaviren
- Bakterien: Campylobacter jejuni, Salmonellen, Yersinien, verschiedene Escherichia coli-Stämme (wie EHEC und ETEC), Shigellen und Vibrio cholerae
- Parasiten: Giardia lamblia und Entamoeba histolytica

Was muss man bei Salmonella machen?

Warum ist Salmonella meldepflichtig? Gefährlich für die Bevölkerung, extrem ansteckend

Warum hat sie die S nach dem Essen? Weil die Magenschleimhaut entzündet sein muss

Was ist Mettbrötchen? = belegtes Brötchen mit rohem Schweinehackfleisch, das oft mit Zwiebeln garniert wird und besonders in Norddeutschland als Snack beliebt ist.

Was passiert mit dem Essen, das ungekocht ist? Viele Bakterien (Salmonella, E.Coli, Listeriose) / Parasiten (Toxoplasmose, Trichinose) sammeln

Warum N und V gleichzeitig? Schutzmechanismen des Körpers

Was ist Baldrian? = eine Heilpflanze zur Beruhigung und zur Förderung des Schlafs

Was macht eine Taxifahrerin? Sie transportiert Fahrgäste gegen Bezahlung von einem Ort zum anderen. Sie sitzt dann immer und bewegt sich nur sehr wenig

Warum GE? Was hat er dagegen? Die Patientin hatte wahrscheinlich eine gastrointestinale Infektion durch den Verzehr von verdorbenem Mettbrötchen und Tiramisu, was die Symptome verursacht hat.
bezüglich

Warum haben die Gerichte eine GE verursacht? Weil sie nicht frisch waren und Bakterien oder Viren enthielten. ← enthalten
komma

Häufigste Erreger der GE (Bakterien, Viren)? Zu den häufigsten Erregern von GE gehören Viren (Noroviren, Rotaviren) sowie Bakterien (Salmonellen, Campylobacter und E.Coli)
häufigste

Was muss man bei Salmonella machen? Bei Salmonellen-Infektionen ist eine strenge Hygiene wichtig, und bei schweren Fällen kann eine antibiotische Behandlung notwendig sein.

Warum ist Salmonella meldepflichtig? Weil sie Gefährlich für die Bevölkerung und hoch ansteckend sind.

DD:

- **Lebensmittelvergiftung**: Dies könnte durch Bakterien wie Salmonellen, Escherichia coli oder Campylobacter verursacht werden, die oft in rohen oder schlecht gelagerten Lebensmitteln vorkommen.
  - = eine meist in Form einer Gastroenteritis verlaufende Intoxikation, die durch die orale Aufnahme von Giftstoffen mit der gewöhnlichen Nahrung entsteht
  - Die häufigste Ursache von Lebensmittelintoxikationen sind bakterielle Exotoxine bzw. Enterotoxine (häufiger Toxinproduzent Staph, seltener Bacillus cereus oder Clostridien)

- **Gastro-duodenales Ulkus**: Dies könnte die epigastrische Schmerzursache und das Erbrechen erklären und gastrointestinale Blutung ☐ die dunkelrote Farbe des Stuhls könnte auf Blut hinweisen, wobei dies überprüft werden müsste
- **Appendizitis**: Obwohl die Schmerzen häufig im Epigastrium beginnen, wandern sie in der Regel in den rechten Unterbauch. Die anfänglichen Symptome können jedoch Erbrechen und Bauchschmerzen umfassen.
- **Reizdarmsyndrom** (RDS): Obwohl eher chronisch, kann ein akuter Schub Schmerzen und Durchfall verursachen.

Warum akute Pankreatitis? Wie sieht der Stuhl bei Pankreatitis aus? Acholischer Stuhl, Steatorrhö

Könnte M.Crohn, Peritonitis sein? in Betracht ziehen -> dissoto almo>, dragulendurchz
in Betracht gezogen werden -, digokindulmo>, durchbluten

- Morbus Crohn könnte in Betracht gezogen werden, wenn **chronische** oder **wiederkehrende** Symptome wie Bauchschmerzen, Durchfall und **Gewichtsverlust** vorliegen.
- Peritonitis könnte eine Differenzialdiagnose sein, wenn Anzeichen einer schweren abdominalen Entzündung mit einem **akuten Abdomen**, Fieber und einer **Verschlechterung des Allgemeinzustands** vorhanden sind.

Wie machen Sie weiter? Was erwarten Sie bei Laboruntersuchung? Bei der Laboruntersuchung erwarte ich erhöhte Entzündungsmarker wie C-reaktives Protein (CRP), erhöhte Leukozytenzahl, mögliche Anomalien bei den Elektrolyten

Erhöhte MCV, G-GT, GOT? => viel Alkohol

Welche anderen Krankheiten müssen Sie ausschließen? Hb: 10,6 => warum? Chronischer Blutung (Kolon-CA, Ulcus)
akute Blutung.. Hb ↓ MCV Normal
chronische Blutung.. Hb↓ MCV ↓ (Dem c>>>i>>>ortho cistrien kopfmodell)

Welche Untersuchungen/Blutwerte sind wichtig beim Blut im Stuhl? FOBT, Erythrozytenindizes

um den Erreger zu identifizieren

Warum Stuhluntersuchung? Wonach suchen Sie im Stuhl? Im Stuhl suchen wir nach Anzeichen von Infektionen durch **pathogene Bakterien**, **Viren** oder **Parasiten**, nach **Blut** oder **Schleim**, sowie nach **Fett** (Steatorrhö), was auf eine malabsorbierende Erkrankung wie Pankreatitis hinweisen könnte.

Wie entdecken wir Bakterien im Stuhl? besyei ausbringen ezmek

- **Stuhlkultur**: Eine Stuhlprobe wird auf spezielle Nährmedien ausgebracht, um Bakterien wachsen zu lassen. Diese Kultur wird dann untersucht, um die Art der Bakterien zu identifizieren.
- **Mikroskopische** Untersuchung: Direktes Mikroskopieren des Stuhls, um das Vorhandensein von Bakterien, Parasiten oder deren Eiern zu erkennen.
- **Molekulare** Tests: Testmethoden wie PCR (Polymerase-Kettenreaktion) können spezifische genetische Materialien von Bakterien nachweisen.

Stationär oder ambulant? Stationär wegen Blut im Stuhl

Ursachen von Anämie? Retikulozytenproduktionsindex (RPI):

- <2: hyporegeneratorische Anämie
- >2: hyperregeneratorische Anämie

Wie ist die SD-OP durchgeführt? Eine Schilddrüsen-OP erfolgt klassischerweise durch **einen vier bis fünf** Zentimeter langen Hautschnitt im unteren Halsbereich (Kocher-Kragenschnitt).

- Strumaresektion = partielle Resektion (Teilentfernung)
- Thyreoidektomie = totale Resektion (Vollentfernung)

Perine Pelvis toborn dishi gönüncüzüm

Unterschied zwischen Darm und Damm? Darm = Intestinum, Damm = Perineum

Notaufnahme

Was sind die Wichtigsten in NA? KU, Monitoring, Labor, EKG, ggf.Sono

O2 sättigung
RR
Puls
Temperatur
Atemfrequenz
ggf. Schmerzskala

Typen von ACS? STEMI, NSTEMI, instabile Angina Pectoris

Welche Impfungen sind in Deutschland pflichtig? von der STIKO empfohlene

- 6-fach-Impfstoff gegen:
    - Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung (Poliomyelitis),
    - Haemophilus influenzae Typ b (Hib),
    - Keuchhusten (Pertussis)
    - Hepatitis B
- sowie die Kombinationsimpfstoffe gegen Masern, Mumps, Röteln (MMR)
- und ggf. Windpocken (MMRV)

Teilumsetzbarkeit

Was ist Herdimmunität? beschreibt den Zustand, bei dem ein großer Teil der Bevölkerung gegen eine Infektionskrankheit immun ist, sodass die Ausbreitung der Krankheit in der Gemeinschaft stark eingeschränkt wird und auch Personen, die nicht immun sind, geschützt werden.

Welche Arten von Arthritis kennen Sie?

- **Rheumatoide Arthritis**: = chronische Autoimmunerkrankung, die hauptsächlich die Gelenke betrifft.
- **Osteoarthritis**: = degenerative Gelenkerkrankung, die durch Verschleiß des Knorpels verursacht wird.
- **Gicht**: = Form der Arthritis, die durch Ablagerungen von Harnsäurekristallen in den Gelenken verursacht wird.
- **Psoriasis-Arthritis**: = Form von Arthritis, die bei Patienten mit Schuppenflechte (Psoriasis) auftreten kann.
- **Juvenile Arthritis**: Arthritis, die bei Kindern und Jugendlichen diagnostiziert wird.

Warum Schaufenster? (= Claudicatio intermittens pAVK) aufgrund von Schmerzen beim Gehen **häufig anhalten müssen** und sich dann so verhalten, als ob sie sich die Schaufenster ansehen würden, um die Schmerzen zu verbergen.

sie heißt Schaufensterkrankheit, weil die Patienten wegen Schmerzen immer wieder stehen bleiben müssen - so sieht es aus, als würden sie sich die Schaufenster ansehen.

Stadium		Symptomatik
Stadium I		symptomfrei, meist klinischer Zufallsbefund (z.B. fehlende periphere Pulse)
Stadium II		Claudicatio intermittens
	IIa	beschwerdefreie Gehstrecke > 200 m
	IIb	beschwerdefreie Gehstrecke < 200 m
Stadium III		Ruheschmerz
Stadium IV		Trophische Störungen (Nekrosen, Ulzera, Gangrän)

RF für Apoplexie? Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel, hohe Cholesterinwerte, Vorhofflimmern und familiäre Vorbelastung.

Röntgen von Corona?

- Beidseitige Infiltrate („milchglasartige" Verschattungen) / **Periphere subpleurale Milchglastrübungen**
- Periphere und basale Lungenveränderungen
- Multifokale Konsolidierungen in schweren Fällen

Crazy-Paving-Muster (Septumverdickung)

Was ist Methadon-Programm? eine medizinische Behandlung für Menschen mit Opioidabhängigkeit, bei der Methadon als Ersatzmittel eingesetzt wird, um Entzugserscheinungen zu lindern und die Sucht **schrittweise** zu überwinden.

Was ist Silberhochzeit? 25. Hochzeitstag (Vierteljahrhundert ihrer Ehe)

Empfehlungen für Kinder mit GE?

- Hydratation
- Ernährung: BRAT-Diät (Bananen, Reis, Apfelmus, und Toast)
- Medikamente: gegen Durchfall (Racecadotril zB Vaprino), gegen Erbrechen (Dimenhydrinat zB Vomex A)
- Hygiene: regelmässiges Händewaschen
- Zu Hause bleiben (mindestens 48 Stunden)

Was ist Kanzlei? Büro eines Rechtanwaltes (sie bieten Beratungs- und Dienstleistungen in rechtlichen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten an)

11. Mesenterialinfarkt s.87

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Schnell aber deutlich/ manchmal leise

- Gisela Reuters
- 63 J.
- *01.02.1959
- 1,65 m
- 71,3 kg
- Ich möchte dieses Gespräch nicht führen. Warum? Ich möchte lieber einen deutschen Arzt.
    - Ja das ist möglich. Allerdings sind die anderen Ärzte alle beschäftigt, deshalb sollen Sie noch einige Stunden warten bis sie Zeit für Sie haben. Aber ich kann mich jetzt gerne gleich um Sie kümmern.

-Hauptbeschwerden

- Bauchschmerzen
    - **Seit 1,5 Stunden (anderthalb Stunde)**
    - **Periumbilikal:** um meinen Bauchnabel
    - **Kolikartig:** wehenförmig
    - **ohne Ausstrahlung**
    - Nach dem Frühstück **(postprandial)**
    - **plötzlich angefangen:** Hatten Sie früher solche Beschwerden?
    - **NRS: 8-9/10**
    - **Seit 4 Wo. dumpfe diffuse progrediente Bauchschmerzen:** seit 4 Wochen habe ich diese Schmerzen, aber anfangs waren sie dumpf, diffus und erträglich. Aber seit 1,5 Stunden sind sie unerträglich geworden!
- **Hyperhidrose:** ich habe auch viel Schweißausbruch
- **Tachykardie:** Herzrasen
- **Nausea:** Übelkeit
- Stuhl- und Windverhalt Blähung?
- Gehen Winde ab?

Akute Gastroenteritis

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Iris Weber
Alter: 55 Jahre (geb. am 12.12.1969)
Größe: 1,73 m
Gewicht: 67 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- Seit gestern Abend, langsam aufgetretene, kolikartige, wellenformige, persistierende und progrediente Bauchschmerzen im Epigastrium, ohne Ausstrahlung.
- Die Schmerzintensität: 5/10 auf der NRS
- Auslöser: Verzehr von Mettbrötchen und Tiramisu
- Lindernde Faktoren: Emesis
- Verstärkende Faktoren: Bewegung
- Begleitsymptome:
  - Nausea
  - Emesis: 3-mal (gelblich, schleimig, mit unverdautem Essen)
  - Diarrhö: 4-5-Mal seit heute Morgen, wässrig, schaumig, zunächst hellrot, später dunkelrot.

V/A:

Fieber: (gestern: 39 °C, heute: 38,8 °C, axillar gemessen)
Inappetenz
Müdigkeit
stressbedingte Insomnie

Gyn:

Menopause: seit 7 J.
Forcepsentbindung/Vakuumextraktion bei der Geburt ihrer Tochter

V/E:

Kopfschmerzen: bds., drückend, 2 Mal/M
chronischer Husten

M:

Baldrian b.B.
ASS 500mg b.B. (wegen Kopfschmerzen)
Maaloxan (wegen Bauchschmerzen)

Vor-op:

Unauffällig

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Penicillin (Dyspnoe)

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: 10 Zig./Tag, seit dem 16. Lj.
- Alkoholkonsum: 2 Gl. Wein/Wo., gelegentlich. Bier.

- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**
  Taxifahrerin
  geschieden
  eine Tochter: ex-Drogenabusus, derzeit Methadon-Substitution

- **Familienanamnese:**
  Vater: verst. mit dem 45 Lj. an MI.
  Mutter: verst. Mit dem 65 Lj. an Mammakarzinom.

- **Verdachtsdiagnose:**
  Akute Gastroenteritis

- **Differentialdiagnose**
  Akute Pankreatitis
  Divertikulitis
  Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen

- **weitere Diagnostik**
- KU
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Elektrolyte - Amylase und Lipase
- Stuhluntersuchung
- Sono Abdomen
- Ggf CT Abdomen

- **Therapievorschläge**
- Stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution (Infusionstherapie)
- Antipyretikum
- Antiemetikum
- Analgetikum (Metamizol) b.B.
- Magenschonende Ernährung (Kartoffeln, Reis und Apfel)
- Nikotinkarenz , Alkoholkarenz
- Ggf. Antibiotikum (Ciprofloxacin)

Patient/in

Heiko Weißhaupt
47J. 03.05.1978
1.67 m 69.5kg

Akute Gastroenteritis

Bukosta
UEida
Reizdarm
sizyphilis
ederse DD:
Reizdarmsyndr.

aktuelle Beschwerde

Leitsymptome — Hauptbeschwerden:

- Bauchschmerzen im Oberbauch, seit gestern Abend bestehend
- langsam postprandial aufgetreten (nach dem Verzehr von Mettbrötchen und Tiramisu)
- krampfartig, wellenförmig, persistierend,
- ohne Ausstrahlung
- 6/10 auf der Schmerzskala (bei ~~mit~~ Krämpfen), 3/10 (ohne Krämpfe)
- Verstärkende Faktoren: Bewegung
- Lindernde Faktoren: Hinlegen

Begleitsymptome

- Nausea
- Fieber (gestern Abend: 39 °C heute: 38,3 °C)
- Vomitus, heute Morgen, 1 Mal, gelblich, mit Speiseresten ohne Blut
- Diarrhoe, heute Morgen seit 5 Uhr, 7-8 Mal, wässrig, schaumig, zunächst hellrot später ~~bräunlich~~, dunkelrot
- Völlegefühl
- Müdigkeit

Vegetativanamnese

- Appetenz

(VE) Gyn: Vorerkrankungen

- chronischer Raucherhusten seit längerer Zeit
- 2x Pleuritis, mit Konservativ behandelt wurde

Vor-OPs:

- Inguinalhernie-OP, rechts vor 10 Jahren

(Medi) Medikamentenanamnese

- ASS 500 mg b.B.
- Macrolon b.B.

Allergie/Unverträglichkeit

- Penicillin (~~Atemnot~~ Dyspnoe, Erbrechen, Exanthem, ~~Pruritus~~ Pruritus)

Genussmittel

Nikotin: 15 Zigaretten täglich seit 20 Jahren (15 py)
Alkohol: 1-2 Gläser Bier jeden Abend
Drogen: unauffällig

Sozialanamnese

- Busfahrer
- Stress bei der Arbeit und im Privatleben
- geschieden
- eine Tochter, (Drogensüchtig) → ex-Drogenabusus, derzeit Methadon-Substitution
- lebt mit ihrer Partnerin

Familienanamnese

(verstorben mit dem 45 Lj an MI)

Vater: an MI mit 45 Lj. gestorben

Mutter: an Mammakarzinom mit 50 Lj. gestorben

Schwester: gesund

Verdachtsdiagnose

akute Gastroenteritis

Differentialdiagnose

Ulcus ventriculi
Gastritis
akute Pankreatitis

weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter (CRP), Hw? ~~Enzyme~~ Muskelenzyme (Troponin T, I, CKMB), Amylaz, Lipaz, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte
  Stuhldiagnostik (FOBT, Stuhlkultur)
- Ultraschall - Abdomen
- ~~Röntgen - Abdomen~~ ? ggf. CT-Abdomen
- ggf. ÖGD 3ne Koloskopie

Therapie

- stationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr
- Elektrolyt~~substitution~~ substitution
- Magenschonende Ernährung
- Analgetika
- Spasmolytika
- Antiemetika
- Antipyretika
- ggf. Antibiotika (Ciprofloxacin)
  (Ciprofluxacin)

- Nikotinkarenz
- Alkoholkarenz
- ggf. gastroenterologisches Konsil

Erythrozytenindizes (RBC indices)

MCV → eritrosit hacmi

MCH → eritrosit başına Hb miktarı

MCHC → eritrosit içindeki Hb yoğunluğu

Bu değerler düşükse sonuç indirgemede bozulmuş. Düşükse son positif sonuçlara uyarlıdır veya demiryetersizliği anemisi düşündürür. RBC indeksleri anemi.

Bei positivem Blut im Stuhl sind die Erythrozytenindices wichtig, um die Art der Anämie zu bestimmen und zwischen akutem und chronischem Blutverlust zu unterscheiden. Besonders MCV und MCH sind entscheidend für die Diagnose einer Eisenmangelanämie.

RPI → anemi durumunda kemik iliğinin sunum son hücresi üretim hızını gösterir retikülosit ortalama gösteren indeks

Der RPI zeigt, ob das Knochenmark bei einer Anämie ausreichend viele Erythrozyten produziert. Ein RPI > 3 spricht für eine adäquate Markreaktion, während ein RPI < 2 auf eine unzureichende Erythropoese hinweist.

>3	yüksek	Kemik iliği iyi yanıt veriyor. (Akut kan kaybı, hemoliz)
2-3	orta	sınırlı yanıt
2>	düşük	Kemik iliği yetersiz yanıt veriyor (örn. demir eksikliği, B12 eksikliği aplastik anemi)

„
+ Methadon wird Patienten statt anderer Opiate gegeben.
Danach wird die Dosis reduziert, um Abhängigkeit zu verhindern."

vermeiden – kaçınmak
verhindern – önlemek.
schritt für schritt = schrittweise

Dänisch

Klein BB – Groß BD

Das kleine Blutbild zeigt die Anzahl von roten, weißen Blutkörperchen und Thrombozyten.

Das große Blutbild enthält zusätzlich die Aufteilung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten Differenzierung)

ist verdorben – bozulmuş

Die Milch ist verdorben ...

Das Essen war verdorben ...

Haben Sie irgendwo Schmerzen?

Haben Sie noch irgendwelches Problemen?

Seit wann
Dauerhaft
Schmerzintensität
Medikament

Bu 4 soru önemli.